

POSTOPERATİF DÖNEMDE HASTA BAKIM SÜRECİ

**HAZIRLAYANLAR: IŞILAY BAYRAKTAR
FATMA KÜTÜK
NÖROŞİRURJİ SERVİSİ**

POSTOPERATİF DÖNEMDE HASTA BAKIM SÜRECİ

- Çeşitli nedenlerle operasyon girişimi uygulanan hastaların normal vücut fonksiyonlarına geri dönünceye kadar geçen süre postoperatif dönem olarak adlandırılır.
- Bu süreç çeşitli faktörlerin etkisiyle birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayabilir.
- Operasyon, beden için hem fizyolojik hem de psikolojik stresör olduğundan bedenin homeostatik dengesini bozar.
- Bu nedenle postoperatif bakımın **temel amacı “homeostatik dengeyi yeniden düzenlemektir.”**

(Akyolcu , Kanan , Aksoy ,2017).

POSTOPERATİF DÖNEMDE HASTA BAKIM SÜRECİ

Operasyon sonrası süreç üç ayrı aşamadan oluşur.

- 1) **Birinci aşama**, hastanın solunum yolunun, hayati belirtilerinin ve iyileşme göstergelerinin yakından izlendiği Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinde (derlenme) veya yoğun bakım ünitesinde gerçekleşir.
- 2) **İkinci aşama**, hastanın Tıbbi-Cerrahi üniteye transferi ile gerçekleşir.
- 3) **Üçüncü aşama**, hastanın uzman bakım tesisinde veya evinde, genişletilmiş bakım ortamına geçişini ifade eder.

(Glick, 2022).

Tıbbi-Cerrahi Üniteye Transfer

Derlenme hemşiresinden servis hemşiresine devir teslim raporunun kritik bileşenleri şunlardır:

- ❖ Ağrı ve bilinç düzeyi gibi fiziksel değerlendirme verileri
- ❖ İşlemin Türü/Kapsamı
- ❖ Anestezi Türü/Süresi
- ❖ Alerjiler
- ❖ Sağlık Sorunları
- ❖ Vital Bulgular
- ❖ IV Sıvılar/İlaçlar
- ❖ Tahmini Kan Kaybı

AMELİYATHANEDEN SERVİSE TESLİM		KONTROL KRİTERLERİ						EVET	KONTROL EDEN
		Ameliyat Sonrası Hasta Uyanık						☐	
Solunum Düzenli						☐			
Damar Yolu Açık, Sorunsuz Kontrol Edildi						☐			
Ağrı Kesici		☐ Yapıldı (.....)				☐ Yapılmadı			
Kan Transfüzyonu		☐ Yapıldı (.....)				☐ Yapılmadı			
PCA Takıldı		☐ EVET ☐ Epidural ☐ IV ☐ HAYIR							
Dreni;		☐ Var ☐ Yok ☐ Sonda Takılı ☐ İdrar Çıkışı ☐ Var ☐ Yok							
DOSYA	Güvenli Anestezi	Anestezi Formu	Derlenme Formu	Anestezi Onam	Cerrahi Transfüzyon	Ameliyat Tamamlandı			
POSTOP VİTAL BULGULAR									
ATEŞ	NABİZ	TANSİYON	SOLUNUM/SPO2	DM İŞE KAN ŞEKERİ					
TESLİM EDEN SAĞLIK ÇALIŞANI/İMZA/SAAT				TESLİM ALAN SAĞLIK ÇALIŞANI/İMZA/SAAT					

NOT: Formlar Tam İse ✓, Eksikse — Kullanılır.

(Glick, 2022).

Tıbbi-Cerrahi Üniteye Transfer

- İdrar Çıkışı
- Drenaj Yerleşimi ve Çıkışı
- Ameliyat Sırasında Meydana Gelen Komplikasyonlar
- Duyusal Bozukluklar
- Kesiler/Pansumanlar
- Belirlenmiş Aktivite Kısıtlamaları veya Eklem/Uzuv Hareketsizliği
- Düşük Hemogloblin Yönetimi

Glick, DB (2022).

TIBBİ-CERRAHİ ÜNİTEYE TRANSFER



TIBBİ-CERRAHİ ÜNİTEYE VARIŞTA RUTİN ODAKLI DEĞERLENDİRMELER

- 1.** Solunum sistemi fonksiyonlarının sürdürülmesi
- 2.** Kardiyovasküler fonksiyonların sürdürülmesi
- 3.** Üriner sistem fonksiyonların sürdürülmesi
- 4.** Gastrointestinal fonksiyonların sürdürülmesi
- 5.** Nörolojik sistem fonksiyonlarının Sürdürülmesi
- 6.** Yara iyileşmesinin sürdürülmesi
- 7.** Ağrı yönetimi
- 8.** Vücut sıcaklığının korunması
- 9.** Dinlenmeyi Sağlamak
- 10.** Erken Mobilizasyon
- 11.** Hasta ve aileye psikolojik destek sağlama
- 12.** Taburculuk ve evde bakım

1-SOLUNUM SİSTEMİ FONKSİYONLARININ SÜRDÜRÜLMESİ

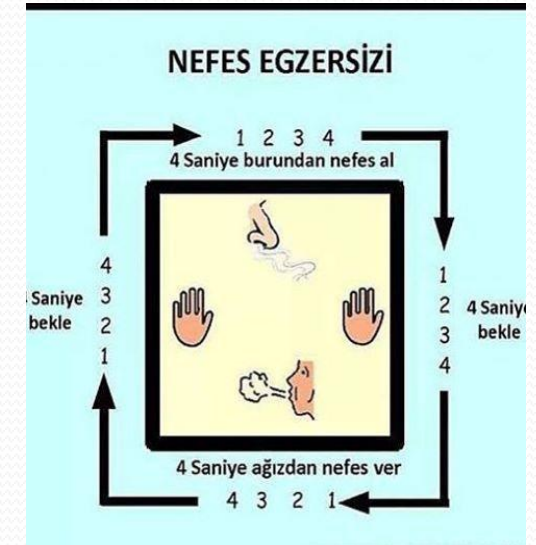
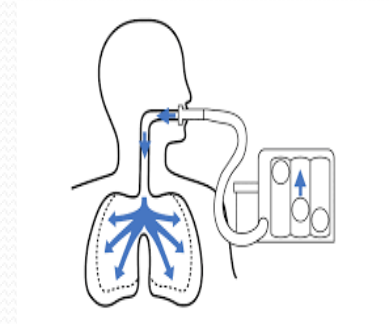
Hemşirelik bakımı olası sorunları belirlemek için tanınması gereken durumlar:

- Solunum sayısı
- Solunum tipi
- Solunum sesi

En çok görülen solunum komplikasyonları:

- Atelektazi
- Pnömoni
- Akciğer ödemi/emboli

Solunum egzersizlerini yapma konusunda hasta desteklenmeli



1-SOLUNUM SİSTEMİ FONKSİYONLARININ SÜRDÜRÜLMESİ

Solunum sistemi fonksiyonlarının sürdürülmesini iyileştirmek için:

- Hasta pozisyonu 1-2 saat ara ile değiştirilir.
- Mümkün olduğunca erken mobilizasyon sağlanır.
- Etkili ventilasyonu engelleyen ağrı kontrol altına alınır.
- Narkotik ilaç kullanılıyorsa solunum ve öksürük refleksinin deprese olma olasılığı izlenmelidir.

Çelik S, Taşdemir N (2018).

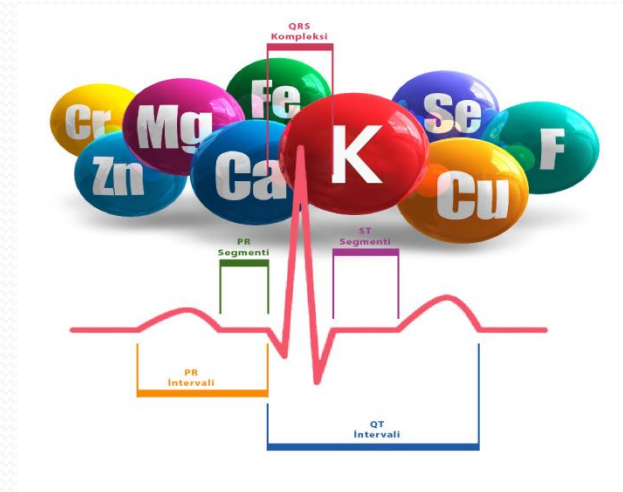
2-KARDİYOVASKÜLER FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Değişiklik oluşturan faktör:

- Sıvı-elektrolit dengesizlikleridir.

Nedenleri: Aşırı sıvı kaybı ve gereksiz sıvı replasmanının oluşturduğu stres tepkisi.

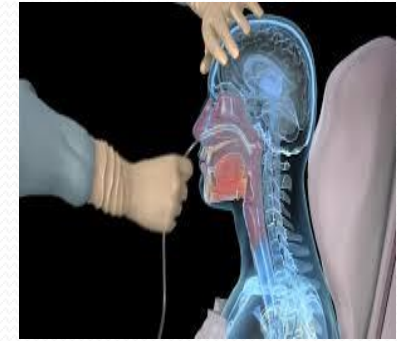
Çelik S, Taşdemir N (2018).



2-KARDİYOVASKÜLER FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Sıvı kaybı nedenleri:

- Yavaş veya yetersiz sıvı replasmanı
- Terleme
- Hiperventilasyon
- Kanama
- Yara drenajı
- GI yol drenajı
- Diyare
- Diürez
- Kusma

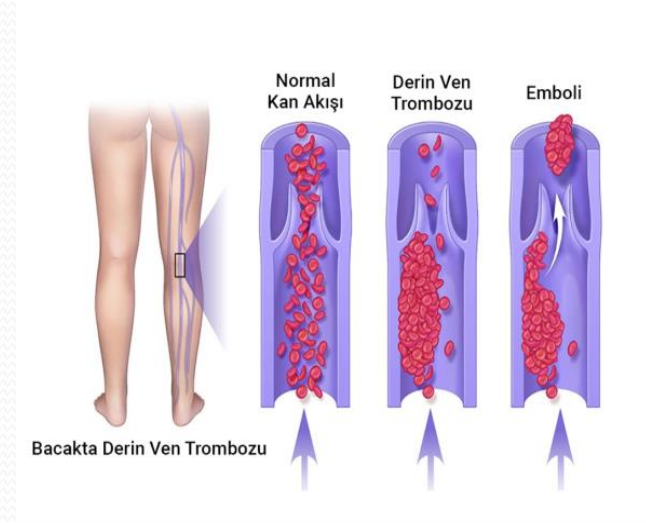
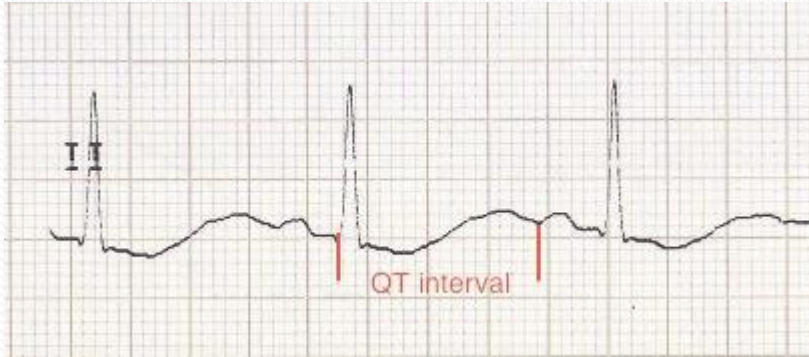


Çelik S, Taşdemir N (2018).

2-KARDİOVASKÜLER FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Komplikasyonlar:

- Derin ven trombozu
- Hipokalemi
- Senkop



Çelik S, Taşdemir N (2018).

2-KARDİYOVASKÜLER FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Hemşirelik Bakımı :

- Hastaların kan basıncı, kalp hızı, cilt sıcaklığı ve rengi düzenli olarak izlenir.
- Hasta pozisyonu dolaşımı kısıtlayıcı olmamalıdır.
- Bilinç açıldıktan sonra yatak içinde dönme-bacak egzersizleri
- Aldığı- çıkardığı ve laboratuvar bulgusu izlemi
- IV sıvıların hızı, miktarı izlenmeli
- DVT'ye karşı önlemler alınmalıdır.



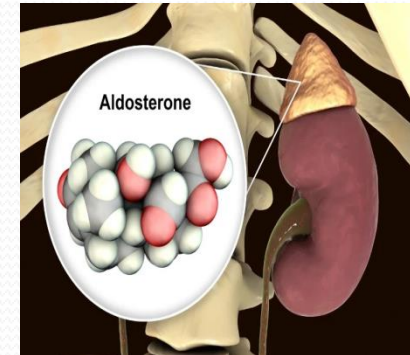
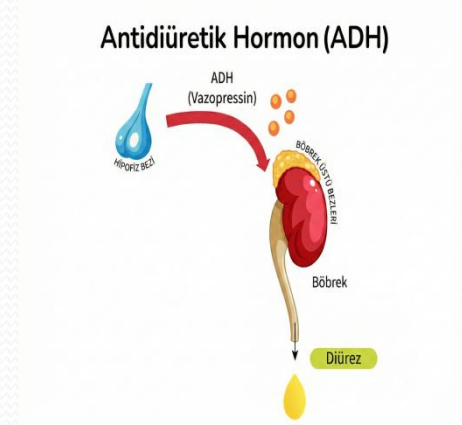
3-ÜRİNER SİSTEM FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Operasyon sonrası sıvı alımına bakılmaksızın ilk 24 saatte oligüri gözlenebilir.

Nedenleri:

- Cerrahi stres nedeniyle ADH ve aldosteron artışı
- Operasyon öncesi sıvı kısıtlaması
- Operasyon sırası drenaj, terleme yoluyla kayıp

Çelik S, Taşdemir N (2018).

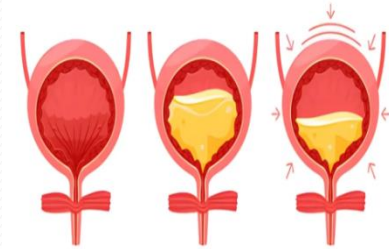


3-ÜRİNER SİSTEM FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

İdrar retansiyonu:

- Cerrahi girişim sırasında miksiyon işlevini gerçekleştiren batın ve pelvis kaslarının spazmı nedeniyle, alt batın ve pelvis cerrahisi sonrası görülür.
- Hareketsizlik ve rekümbent pozisyonunda yatma idrar atımını bozabilir.

Çelik S, Taşdemir N (2018).



3-ÜRİNER SİSTEM FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Hemşirelik Bakımı

- İdrar nitelik ve nicelik açısından izlenir.
- Kateter varsa idrar atımı saatte ortalama 50 ml olmalı.
- Operasyon sonrası 6-8 saat içinde hasta idrara çıkar.
- Aksi durumda distansiyon değerlendirilmeli.
- İdrar çıkışını kolaylaştıracak pozisyon verilmeli.
- Operasyon sonrası 8-10 saat içinde idrar çıkışı olmazsa idrar çıkışını kolaylaştıran yöntemler denenmeli.
- Son çare geçici kateter



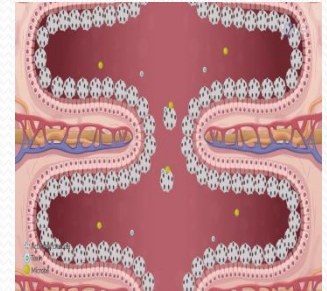
4-GASTROİNTESTİNAL FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Değişiklik oluşturan faktörler:

- Gİ motilitenin azalması
- Beslenme alışkanlığının değişmesi

Değişikliğe bağlı gelişen semptomlar:

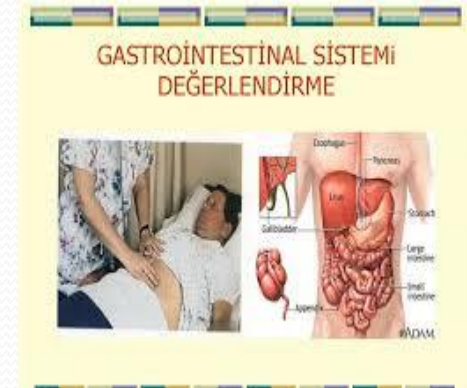
- Bulantı-kusma
- Abdominal distansiyon
- Hıçkırık



4-GASTROİNTESTİNAL FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Hemşirelik bakımı:

- ❖ Bağırsak sesleri kontrol edilir.
- ❖ Ağız bakımı ile susama hissi yönetilir.
- ❖ NG tüp takılı ise aspirasyon riski kontrol altına alınmalı.
- ❖ Oral beslenmeye geçişle birlikte sıvı ve yumuşak gıdalar ile beslenme yönetilir.
- ❖ Erken ve sık mobilizasyon ile bağırsak motilitesini uyarma



https://adm.atauni.edu.tr/pluginfile.php/1717/mod_resource/content/1/14.%20Hafız%20Ameliyat%20%20sonras%C4%B1.pdf

- Bilinç Durumu
- Oryantasyon
- Pupil Kontrolü
- Motor ve Duyusal Fonksiyonlar
- Hayati Bulgular
- Konuşma ve Anlama
- Deliryum Değerlendirmesi

Glaskow Koma Skoru (GKS)



ACIL ÇALIŞANLARI
"Hayatı Hayatlı Tutmak"
www.acilci.com.tr

➤ Travma

TRAVMA

Göz Açma	Puan
Spontan	4
Sözlü Uyarımla	3
Ağrılı Uyarımla	2
Cevap Yok	1

Sözel Cevap	Puan
Oryante Konuşabilir	5
Dezorganize Konuşur	4
Uyumsuz Sözlür	3
Anlamsız Sesler	2
Cevap Yok	1

Motor Cevap	Puan
Emirleri Yeriye Getirir	6
Ağrılı Uyarımla Lokalize Ediyor	5
Extremitede Fleksiyon Yanıt	4
Dekortike Postür (Fleksiyon)	3
Desere Postür (Eksansiyon)	2
Cevap Yok	1



ACIL ÇALIŞANLARI ACIL KURTULAM SİSİ

ACIL ÇALIŞANLARI

İzmirin ACIL ÇALIŞANLARI





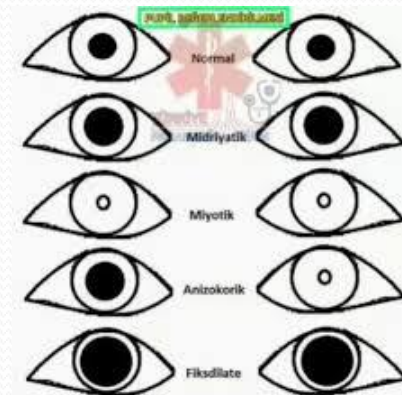
bizi takip /





Hayatı Hayatlı Tutmak
Bilgiye Adanmış

www.acilci.com.tr



5-NÖROLOJİK SİSTEM FONKSİYONLARININ SÜRDÜRÜLMESİ

Komplikasyonlar

- ✓ Deliryum
- ✓ Postoperatif bilişsel disfonksiyon
- ✓ Nöbetler
- ✓ Hipoksiye bağlı beyin fonksiyon bozuklukları

Evered ve ark.,(2021)



5-NÖROLOJİK SİSTEM FONKSİYONLARININ SÜRDÜRÜLMESİ

Hemşirelik Bakımı:

- ✧ Solunum Yönetimi
- ✧ Pozisyonlandırma
- ✧ Güvenlik
- ✧ Nutrisyon ve Hidrasyon
- ✧ Ağrı yönetimi
- ✧ Komplikasyonları Önleme
- ✧ Erken Mobilizasyon
- ✧ Hasta ve Aile Eğitimi



Topçuoğlu, M.A. (2020).

6-YARA İYİLEŞMESİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

- # İyileşmede stres faktörler ve komplikasyonlar önemlidir.
- # Kritik zaman ilk 24-72 saattir.
- # Bu süre yaranın enfekte olması ile 2 ila 6 güne uzayabilir.
- # Temiz yara, normal gerilme kuvvetini girişim sonrası 15-20 günde kazanır.
- # Operasyon öncesi iyi beslenme olumlu etkiler.
- # Beslenme bozukluğu oluşturan kronik hastalıklar iyileşme sorunlarını artırır.

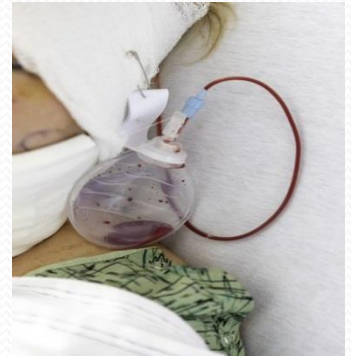
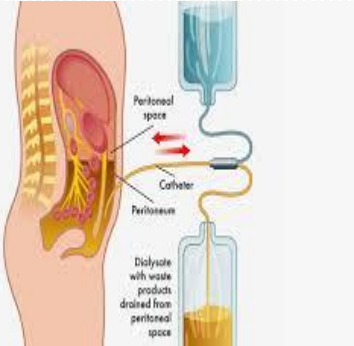
6-YARA İYİLEŞMESİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

Yara bakımı önemlidir.

- ✚ Temiz ve kuru tutulmalıdır.
- ✚ Aseptik teknik yara bakımında gereklidir.
- ✚ Drenajın tipi, miktarı, içeriği kaydedilmelidir.
- ✚ Pansuman; kanayan, sızıntılı fazla drenajı olan yaralar için uygundur.
- ✚ Yara ayrılması, eviserasyon ve enfeksiyon yönünden dikkatli izlem yapılmalıdır.



DREN ÇEŞİTLERİ



7-AĞRI YÖNETİMİ

Algısal, duyuşal, düşünşel pek çok faktör ağrı algışını etkiler.

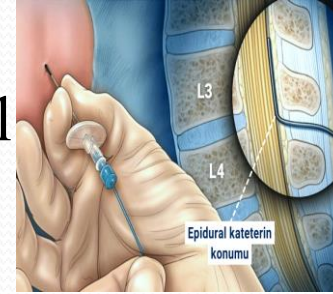
Kontrol altına alınamayan ağrı:

- ◆ Aktivitelerde sınırlılık
- ◆ Solunum ve dolaşım komplikasyonları
- ◆ Sindirim sistemine ait bazı sorunlara neden olur.
- ◆ Şiddetli ağrı; kardiyak ve immün sistemi olumsuz etkiler.



7-AĞRI YÖNETİMİ

- ♪ Hastanın ağrıyı sadece sözel ifadesi beklenmemeli
- ♪ Fiziksel ve psikolojik tepkileri de değerlendirilmeli
- ♪ Ağrının değerlendirilmesi ve takibinde algısal ve emosyonel duruma uygun ölçekler kullanılmalı
- ♪ Ağrı tedavisinde sistemik ve bölgesel analjezikler kullanılır.
- ♪ Şiddetli ağrının kontrolünde hasta kontrollü analjezi, epidural analjezi, intraplevral analjezi kullanılan yöntemlerdir.
- ♪ Etkin ağrı yönetiminde analjeziklerin saatinde uygulanması önemlidir.



7-AĞRI YÖNETİMİ

- * Analjeziklerin etkisi, yan etkileri izlenmelidir.
- * İlaç dışı uygulamalarla da ağrı yönetilmeye çalışılmalıdır.
- * Sıcak/soğuk uygulamalar, mentollü kremler, deri uyarımı, masaj, dikkati başka yöne çekme, gevşeme teknikleri ilaç dışı kullanılabilecek yöntemlerdir.



https://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ameliyathane%20Ve%20Ameliyathane%20Sonras%C4%B1%20Bak%C4%B1m.pdf

8-VÜCUT SICAKLIĞININ KORUNMASI

- = Hipotermi ve hipertermiyi belirleyebilmek için vücut sıcaklığı sık sık ölçülmelidir.
- = Genellikle hastalar derlenme ünitesinden kliniğe alındıklarında üşümeden şikayet ederler ve titredikleri görülür.
- = Vücut bu durumda dışardan mekanik olarak ısıtılmalı ve sıcaklık sık sık kontrol edilmelidir.



https://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ameliyathane%20Ve%20Ameliyathane%20Sonras%C4%B1%20Bak%C4%B1m.pdf

9-İSTİRAHATİ SAĞLAMAK

- ❖ Hastanın operasyondan sonra sağlığına kavuşmasında istirahatın önemli rolü vardır.
- ❖ Hastanın yeterince istirahat edebilmesi; operasyon sonrasında görülen ağrı, huzursuzluk, bulantı ve kusma gibi sorunların giderilmesine bağlıdır.

https://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ameliyathane%20Ve%20Ameliyathane%20Sonras%C4%B1%20Bak%C4%B1m.pdf

10-ERKEN MOBİLİZASYON

- Hareketsizliğe bağılı olarak gelişebilecek komplikasyonları önlemek için hastaya derin solunum, öksürük, yatak içinde dönme ve ekstremitte egzersizleri yaptırılır.
- Hastanın operasyondan sonra en kısa sürede kendi bakımını üstlenmesi sağlanarak hareketsizliği önlenabilir.
- Erken dönemde hasta mobilize edilir.
- Hasta mobilize olmadan önce yatakta oturtulur, bir müddet beklenir, nabzına bakılır, baş dönmesi olup olmadığı sorulur.
- Hasta iyi ise bacakları yataktan aşağı indirilerek terlikleri giydirilir ve ayağı kaldırılır.
- Mobilizasyonun süresi hastanın durumuna göre ayarlanır.



11-HASTA VE AİLEYE PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLAMA

Hasta ve ailesinde anksiyete nedenleri:

- Bilinmeyen yabancı ortamda bulunma
- Ağrı
- Cerrahinin uzun dönem etkilerinden korkma
- Kendine bakabilme gücünü yitirme
- Halsizlik
- Rol ve sorumluluklarda değişiklik
- Beden imajında değişme
- Cerrahi deneyime karşı olası reaksiyonlar



12-TABURCULUK VE EVDE BAKIM

- ❖ Taburculuk eğitimi hastaneye kabulle başlar.
- ❖ Bilgilendirme hastanın bireysel bakım sorumluluğunu almasına hazırlıktır.

Eğitim konuları:

- Yara bakımı
- İlaç kullanımı
- Beslenme
- Kişisel hijyen
- İzin verilen ve kısıtlanan aktiviteler
- Rapor edilmesi gereken durumlar
- Kontrol için ne zaman, nereye baş vuracağı
- Herhangi bir soru ya da sorun olduğunda başvurulacak kurum ya da kişi

GENEL HEMŐİRELİK BAKIMI



GENEL HEMŐİRELİK BAKIMI

- Hastanın birime döndüğü saat kaydedilir.
- Yaşam bulguları alınır.
- Havayolu ve solunum sesleri tanılanır.
- Ekstremitelerin hareketini ve bilinç düzeyini içeren nörolojik durum tanılanır.
- Yara, pansuman ve drenaj tüpleri tanılanır.
- Drenajın tipi, miktarı kaydedilir.
- Drenaj tüpü yerçekimine uygun olarak bırakılır ya da aspiratöre bağlanır.
- Cildin görünümü ve rengi tanılanır.
- İdrar durumu tanılanır.

(Glick, 2022).

GENEL HEMŞİRELİK BAKIMI

- İdrarı boşaltma zamanı kaydedilir.
- Mesane distansiyonu ve boşaltım zorluğu olup olmadığı kontrol edilir.
- Ağrı ve rahatsızlık tanılanır.
- Ağrı kontrolünün nasıl yapıldığı ve son doz kaydedilir.
- Ağrının şiddeti kaydedilir.
- Havayolu açıklığının sürekliliği ve güvenlik için uygun pozisyon verilir.
- IV infüzyonlar kontrol edilir.
- Solüsyon tipi kaydedilir.

(Glick, 2022).

GENEL HEMŞİRELİK BAKIMI

- Kalan sıvı miktarı kaydedilir.
- Sıvının akış hızı kaydedilir.
- Kateterin yeterliği kaydedilir.
- Kateterin numarası ve giriş alanının bütünlüğü kontrol edilir.
- Çağrı zili bağlanır ve hastanın kullanabilme durumu kontrol edilir.
- Bulantı kusma için küvet ve kağıt havlu sağlanır.
- Emosyonel durum ve destekler tanımlanır.
- Aile üyeleri ya da diğer önemli kişilerin varlığı kontrol edilir.
- Hasta ve ailesinin çevreye oryantasyonu sağlanır.
- Operasyon sonrası istemler kontrol edilir ve uygulanır.

(Glick, 2022).

KAYNAKÇA

- Akyolcu N, Kanan N, Aksoy G. (Ed). (2017). Cerrahi Hemşireliği 1-2. Nobel Tıp Kitabevi. ISBN: 97-860-533-529-52.
- Çelik S, Taşdemir N (2018). Güncel Yöntemlerle Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Çukurova Nobel Tıp Kitabevi
- Evered ve ark.,(2021). Recommendation for the nomenclature of cognitive change associated with anaesthesia and surgery. British Journal of Anaesthesia, 126(1),35-48.
- Glick, DB (2022). Yetişkin hastalarda anestezi sonrası bakımın genel görünümü
- https://adm.atauni.edu.tr/pluginfile.php/1717/mod_resource/content/1/14.%20Hafta%20Ameliyat%20%20sonras%C4%B1.pdf
- https://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ameliyathane%20Ve%20Ameliyathane%20Sonras%C4%B1%20Bak%C4%B1m.pdf
- Topçuoğlu, M.A. (2020). İnme hemşireliği ve nörolojik izlem.Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi,26(1), 1-10.
- Yılmaz & Aydın (2023).Nörolojik sistem değerlendirmesi ve hemşirelik yaklaşımları